

IDC Pal ITA: Strumento diagnostico della complessità in cure palliative

Paziente: _____ Data: _____

		Elementi	LC*	✓
1. Dipendenti dal paziente	1.1. Contesto	1.1a Il paziente è un bambino o un adolescente	AC	
		1.1b Il paziente è un professionista sanitario	C	
		1.1c Ruolo socio-familiare svolto dal paziente	C	
		1.1d Il paziente ha una disabilità fisica, mentale o sensoriale precedente	C	
		1.1e Il paziente ha problemi di dipendenza, recenti e/o in atto	C	
		1.1f Disturbi mentali preesistenti	C	
	1.2. Condizione clinica	1.2a Sintomi di difficile controllo	AC	
		1.2b Sintomi refrattari	AC	
		1.2c Condizioni di urgenza in paziente oncologico in fase terminale	AC	
		1.2d Condizioni di fine vita (ultimi giorni) di difficile controllo	AC	
		1.2e Condizioni cliniche secondarie a progressione neoplastica di difficile gestione	AC	
		1.2f Scompenso acuto in insufficienza d'organo in paziente non oncologico in fase terminale	C	
		1.2g Gravi disturbi cognitivi	C	
		1.2h Improvvisi cambiamenti del livello di autonomia funzionale	C	
		1.2i Esistenza di comorbidità di difficile controllo	C	
		1.2j Sindrome cachettica - anoressia grave	C	
		1.2k Gestione clinica di difficile presa in carico/assente aderenza terapeutica	C	
	1.3. Condizione psico-emotiva	1.3a Il paziente presenta un rischio di suicidio	AC	
		1.3b Il paziente richiede di accelerare/anticipare il processo di morte	AC	
		1.3c Il paziente presenta angosce esistenziali e/o sofferenze spirituali	AC	
		1.3d Contrasti nella comunicazione tra paziente e famiglia	C	
		1.3e Contrasti nella comunicazione tra paziente e equipe terapeutica	C	
		1.3f Il paziente presenta gravi e persistenti difficoltà nell'adattamento emotivo	C	
2. Dipendenti dalla famiglia e dall'ambiente		2.a Assenza di insufficienza del supporto familiare e/o del caregiver	AC	
		2.b Famiglia e/o caregiver non competenti per l'assistenza	AC	
		2.c Famiglia disfunzionale	AC	
		2.d Famiglia non più in grado di rispondere ai bisogni del paziente	AC	
		2.e Problemi relativi al lutto	C	
		2.f Limitazioni strutturali dell'ambiente	AC	
3. Dipendenti dall'organizzazione sanitaria	3.1. Sanitari	3.1a Sedazione palliativa di difficile gestione	AC	
		3.1b Difficile gestione farmacologica	C	
		3.1c Difficile gestione degli interventi	C	
		3.1d Limiti nella competenza professionale per affrontare la situazione	C	
	3.2. Risorse	3.2a Difficoltà nella gestione di tecniche strumentali e/o materiali specifici a domicilio	C	
		3.2b Difficoltà nel coordinamento o nella logistica dell'assistenza	C	

*LC → Livello di complessità

C: Elementi di complessità

AC: Elementi di Alta Complessità

Situazione: ☐ Non complessa ☐ Complessa

☐ Altamente Complessa

1. Elementi dipendenti dal paziente

1.1. Contesto

1.1a	Si considera il periodo di vita dalla nascita al completo sviluppo dell'organismo (infanzia e adolescenza fino a 18 anni).
1.1b	Quando il fatto di essere un professionista della salute aggiunge difficoltà alla sua situazione o al processo decisionale.
1.1c	Situazioni in cui il ruolo svolto dal paziente, nel suo ambiente socio-familiare, è determinante: è un elemento importante di coesione familiare; si occupa di minorenni o persone con un alto livello di dipendenza; è giovane; è l'unica fonte di reddito, ecc.
1.1d	Quando queste situazioni rendono difficile fornire assistenza, comunicare e/o comprendere.
1.1e	Quando la dipendenza da alcol, droghe, psicofarmaci, ecc. rende difficile fornire assistenza.
1.1f	Ansia, sintomi depressivi maggiori, sintomi psicotici, ecc. o qualsiasi altra manifestazione di precedenti disturbi mentali che aggiunge difficoltà alla situazione.

1.2. Condizione clinica

1.2a	Presenza di sintomi il cui adeguato controllo richiede un intervento terapeutico complesso, che richiede competenze specifiche sia dal punto di vista farmacologico che strumentale e/o psicologico.
1.2b	Presenza di uno o più sintomi che non possono essere adeguatamente controllati, entro un ragionevole lasso di tempo, senza diminuire il livello di coscienza, per cui è da considerare la sedazione palliativa.
1.2c	Insorgere di emorragie, sindrome della vena cava superiore, erniazioni cerebrali per ipertensione endocranica, ipercalcemia, ostruzione intestinale acuta, stato convulsivo, compressione spinale, fratture patologiche, ecc.
1.2d	Quando c'è un controllo insufficiente dei sintomi fisici e/o psico-emotivi, fase agonica protratta, ecc.
1.2e	Presenza di: occlusione intestinale/urinaria; pelvi congelata che causa ostruzione; sindrome da coinvolgimento locoregionale avanzato di testa/collo; carcinosi peritoneale; ulcere tumorali, fistole o altre lesioni della pelle e delle mucose di difficile gestione a causa di dolore, odore, sanguinamento o posizione, ecc.
1.2f	Presenza di insufficienza respiratoria, epatica, renale, cardiaca, cronica in fase avanzata.
1.2g	Delirium, alterazioni cognitive, disturbi comportamentali, demenza, encefalopatie, ecc. difficili da controllare.
1.2h	Improvvisa comparsa di compromissione funzionale, invalidante le attività della vita quotidiana.
1.2i	Quando coesistono diverse patologie, oltre alla malattia primaria, che complicano la gestione clinica.
1.2j	Anoressia, astenia marcata e grave perdita di peso.
1.2k	Assente o scarsa aderenza alle prescrizioni terapeutico-assistenziali che ostacola la corretta gestione della situazione.

1.3. Condizione psico-emotiva

1.3a	Pregressi tentativi di autolesionismo o desiderio suicidario espresso più volte dal paziente.
1.3b	Il paziente chiede ripetutamente di anticipare attivamente il processo di morte.
1.3c	<i>Angoscia esistenziale</i> : irrequietezza e/o intensa sofferenza emotiva nell'affrontare la morte imminente, accompagnata o meno da sentimenti di rimorso, impotenza, fragilità e mancanza di senso. <i>Sofferenza spirituale</i> : conflitto relativo alla trascendenza, ai fini e valori ultimi, o al significato esistenziale proprio di ciascuna persona.
1.3d	Difficoltà in relazione alla comunicazione/informazione su diagnosi, prognosi, opzioni di trattamento e cura, tra paziente e familiari.
1.3e	Difficoltà in relazione alla comunicazione/informazione di diagnosi, prognosi, opzioni di trattamento e cura, tra paziente ed equipe terapeutica.
1.3f	Risposta emotiva inadeguata, mantenuta nel tempo, funzionalmente inutile per il paziente (negazione patologica, senso di colpa, rabbia contro il caregiver, speranza irrealistica, ecc.).

2. Elementi dipendenti dalla famiglia e dall'ambiente

2.a	Mancanza o insufficiente presenza di caregiver.
2.b	La famiglia o i caregivers non sono competenti nel prendersi cura per: • ragioni emotive: i familiari e/o i caregivers presentano segni di blocco emotivo, disturbi adattativi, mancanza di accettazione o negazione della realtà, angoscia, depressione o qualsiasi altra manifestazione di origine emotiva che ostacola o impedisce la corretta assistenza al paziente; • ragioni fisico-funzionali: i familiari e/o i caregivers sono troppo vecchi, troppo giovani o presentano uno stato funzionale, segni di sovraccarico, esaurimento, storia psichiatrica o qualsiasi altra manifestazione di origine fisico-funzionale che ostacola o impedisce la corretta assistenza al paziente; • ragioni sociali o culturali: i familiari e/o i caregivers si trovano in una situazione di emarginazione o esclusione sociale; oppure presentano pregiudizi etici e/o religiosi o culturali che fanno da barriere e ostacolano o impediscono la corretta assistenza al paziente (isolamento sociale, estrema iperprotezione, interventismo e rivendicazioni sistematiche, ...) o qualsiasi altra manifestazione di origine sociale e/o culturale che ostacola o impedisce la corretta assistenza al paziente.
2.c	Famiglia nelle cui dinamiche si verificano gravi conflitti (violenze domestiche, dipendenza, incapacità mentale, ecc.), che influenzano le legami sociali e/o emotivi in modo da ostacolare o impedire un'adeguata e competente assistenza al paziente.
2.d	Esaurimento dei caregivers nell'offrire una risposta adeguata alle molteplici necessità del paziente, causato dall'impatto emotivo, dalle paure e/o dal sovraccarico derivante dall'affrontare la condizione di terminalità del malato.
2.e	I familiari e/o i caregivers presentano lutto anticipatorio, precedenti lutti irrisolti e/o il rischio di un lutto complicato.
2.f	Le condizioni dell'abitazione e/o dell'ambiente non sono adeguate; lontananza geografica dal luogo di residenza; barriere architettoniche che ostacolano l'accesso del paziente o qualsiasi altra caratteristica di origine strutturale che renda difficile od impedisca la corretta assistenza al paziente.

3. Elementi che dipendono dall'organizzazione sanitaria

3.1. Professionisti/Team

3.1a	Sedazione palliativa prolungata nel tempo, utilizzo di farmaci non usuali, necessità di dosaggi elevati o difficile gestione emotiva.
3.1b	Oppioidi: rischio o presenza di gravi effetti collaterali (narcosi, tolleranza rapida, neurotossicità, ecc.); rotazione degli oppioidi. Altri farmaci: uso insolito, farmaci di difficile gestione o di uso ospedaliero, ecc.
3.1c	Interventi palliativi (radioterapia, chemioterapia, endoscopia, chirurgia, blocchi e altre tecniche analgesiche invasive, protesi, ventilazione meccanica, ...); o derivante dall'uso di tecniche strumentali (nutrizione enterale/parenterale, terapia endovenosa, esecuzione di paracentesi e/o cure di difficile gestione, ecc.).
3.1d	Conoscenza e/o motivazione insufficiente nell'approccio palliativo; dilemmi etici e di valori, attitudini e/o credenze; lutto non risolto da parte dei professionisti o dai membri dell'equipe; conflitto all'interno dell'equipe o con altre equipe rispetto al prendere decisioni; sovraccarico di lavoro, ecc.

3.2. Risorse

3.2a	Materiale ortopedico, ossigenoterapia, aerosol-terapia, aspiratore portatile, pompe infusionali, ventilazione meccanica, materiale di consumo, farmaci di uso ospedaliero, ecc.
3.2b	Insufficiente copertura a causa di carenze nella disponibilità dell'equipe di riferimento; difficoltà logistica per gli appuntamenti di consulenza ospedaliera, trasferimenti, ricoveri programmati; uso ripetuto di dispositivi e servizi di emergenza, difficoltà di coordinamento tra i professionisti; gestione di casi di personalità pubbliche, ecc.